

ΕΠΙΣΤΑΣΗ (ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ)

Γενικά: Παρατηρείται συχνότερα κατά τους χειμερινούς μήνες κι όπως όλες οι αιμορραγίες μπορεί να απειλήσει - σπάνια όμως - τη ζωή του ασθενούς. Συνήθως εμφανίζεται σε ηλικίες μικρότερες των 10 ετών και μεγαλύτερες των 50 ετών. Επίσης, οι άντρες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ρινορραγίας από τις γυναίκες.

Διακρίνουμε τις ρινορραγίες, σε πρόσθιες και οπίσθιες. Η πρόσθια σχετίζεται με βλάβες στην κηλίδα του Kiesselbach και αφορά στο 90% των περιπτώσεων (κυρίως σε νέα άτομα), ενώ οπίσθια ρινορραγία έχουμε περίπου στο 10%, από βλάβη στο πλέγμα του Woodruff.

Ιστορικό: Ελέγχουμε για τη συχνότητα και τη διάρκεια της ρινορραγίας, καθώς και για το συμβάν που πιθανώς την πυροδότησε. Εξετάζουμε την ύπαρξη προδιαθεσικών αιτιών, όπως αιμορραγικές νόσοι, παθήσεις ήπατος, νεοπλάσματα ρινός ή αλλού, λευχαιμία, πρόσφατη επέμβαση στη μύτη, λήψη αντιπηκτικών, αλκοολισμός κ.ά. Βασικές αιτίες επίσταξης, είναι:

- Αλλεργίες, λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού ή ξηρότητα του ρινικού βλεννογόνου.
- Δυνατό φύσημα ή «σκάλισμα» της μύτης, που προκάλεσε ρήξη των επιτολής αγγείων.
- Διαταραχές πήξεως του αίματος, κληρονομικές ή από φάρμακα (αντιπηκτικά, ΜΣΑΦ).
- Κατάγματα της ρινός ή της βάσης του κρανίου. Αποκλίνουν ρινικό διάφραγμα.
- Όγκοι της μύτης (ενδοφυτικά θηλώματα, ρινοϊνώματα, μελανώματα), τηλαγγειεκτασίες.
- Ξένα σώματα στη μύτη (σύννηθες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας). Χρήση κοκαΐνης.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ο ασθενής τοποθετείται σε ημιόρθια ή καθιστή θέση, με κλίση της κεφαλής προς τα εμπρός. Εφαρμόζεται πίεση, τοπικά, για 5-10 λεπτά. Η πίεση πρέπει να ασκείται με τον αντίχειρα και τον δείκτη στα μαλακά μέρη της ρινός. Η εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων (gel-ice pack) στη βάση της μύτης (πρόκληση αγγειόσπασμου) βοηθά σημαντικά.
2. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, SpO₂, T°C) και καθησυχάζουμε τον ασθενή. Επί ενδείξεων, εκτελείται ΗΚΓ, γενική αίματος, B/X: AST/ALT, LDH, INR, a-PTT.
3. Με ήπιους χειρισμούς επιχειρούμε αναρρόφηση, για καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας από τα πύγματα και προς διευκόλυνση του εντοπισμού της εστίας της αιμορραγίας.
4. Χορηγούμε αναισθησία, τοπικά, είτε με spray Ξυλοκαΐνης, είτε με τολύπιο βάμβακος ή γάζα, τα οποία είναι εμποτισμένα με **Ξυλοκαΐνη** και **Αδρεναλίνη** (1:1000) σε ίσα μέρη.
5. Εφόσον εντοπιστεί η εστία της αιμορραγίας, επιχειρείται καυτηριασμός των αγγείων με βαμβακοφόρο στελεό με **τριχλωροξεϊκό οξύ 10% (TCA)** ή **Νιτρικό άργυρο (AgNO₃)**. **(Προσοχή: Αν και η αιμορραγία πιθανώς να αφορά και στους δύο ρόθωνες, πρέπει αρχικώς να καυτηριάσουμε μόνο τον έναν, προς αποφυγή διάτρησης του ρινικού διαφράγματος).**
6. Αν δεν εντοπίσουμε την εστία της αιμορραγίας, τότε γίνεται πρόσθιος επιπωματισμός με βαζελινούχες γάζες Jellonet, που αφαιρούνται μετά από 24-36 ώρες. Επίσης, μπορούμε να τοποθετήσουμε ειδικό αιμοστατικό σπόγγο (Merocel, Rapid-Rhino, Nasapore, κ.ά.).
7. Αντιβιοτική αγωγή (Augmentin, Ceclor), για όσες ημέρες διατηρείται ο επιπωματισμός.
8. Εφόσον η αιμορραγία επιμένει και εντοπίζεται προς τον ρινοφάρυγγα, τότε απαιτείται οπίσθιος ρινικός επιπωματισμός, με τη μέθοδο Bellocq, από ειδικό ιατρό-ΩΡΛ.

☞ Ένα «εύκολο τέχνασμα» για την **επίτευξη οπισθίου επιπωματισμού** είναι χρησιμοποιώντας έναν ουροκαθετήρα Foley 10-14 fr, να κόψουμε το τελικό άκρο πέρα από το μπαλόνι και αφού αλείψουμε το άκρο του με γέλη Ξυλοκαΐνης, να εισάγουμε τον καθετήρα (ξεφουσκωτο) από τη μύτη, μέχρις ότου το μπαλόνι να γίνει ορατό από το φάρυγγα λίγο πίσω από την μαλθακή υπερώα. Φουσκώνουμε τότε το μπαλόνι βαθμιαία με νερό ή αέρα και το τραβάμε προς τα έξω, μέχρι να ενσφηνωθεί στη ρινική χοάνη. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή, πρώτα επιχειρείται ο οπίσθιος και κατόπιν ο πρόσθιος ρινικός επιπωματισμός και στη συνέχεια σταθεροποιούμε τις εμποτισμένες γάζες και τον καθετήρα στη μύτη, με αυτοκόλλητες ταινίες. Μπορούμε, επίσης, να εφαρμόσουμε (στις περιπτώσεις που διαθέτουμε στο ΚΥ ή στο ΤΕΠ) τους ειδικούς - για αυτόν τον σκοπό - ρινικούς καθετήρες οπισθίου επιπωματισμού (καθετήρες Brighton ή Bivona).